

Załącznik B.175.

LECZENIE CHORYCH Z ZESPOŁEM ALAGILLE'A (ICD-10 Q44.7)

ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO		
ŚWIADCZENIOBIORCY	SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE	BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU
W programie finansuje się leczenie świądu w przebiegu cholestazy u pacjentów z zespołem Alagille'a: 1) <i>maraliksiybatem</i> zgodnie ze wskazanymi w opisie programu warunkami i kryteriami. 1. Kryteria kwalifikacji - wiek co najmniej 2 miesiące; - stężenie kwasów żółciowych w surowicy powyżej 70 $\mu\text{mol/l}$ w ciągu miesiąca przed kwalifikacją do programu; - w wywiadzie trudny w opanowaniu świąd, tj. wynik w skali ItchRO(Obs) >2,0 w ciągu miesiąca przed kwalifikacją do programu; - cholestaza: tj. stężenie bilirubiny bezpośredniej powyżej 1 mg/dl; - udokumentowany brak skuteczności innych metod leczenia, w tym kwasu ursodeoksycholowego (UDCA) oraz ryfampicyny, po minimum trzech miesiącach leczenia, w optymalnych dawkach na masę ciała; - brak przeciwwskazań do stosowania leku zgodnie z aktualną Charakterystyką Produktu Leczniczego (ChPL);	1. Dawkowanie 1.1. maraliksiyat Dawkowanie i sposób podawania maraliksiybatu – zgodnie z aktualną Charakterystyką Produktu Leczniczego. Leczenie powinien rozpoczynać i nadzorować lekarz mający doświadczenie w leczeniu zespołu Alagille'a.	1. Badania przy kwalifikacji - morfologia krwi z rozmazem; - oznaczenie stężenia kwasów żółciowych; - oznaczenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej (AST); - oznaczenie aktywności aminotransferazy alaninowej (ALT); - oznaczenie aktywności gamma glutamylotransferazy (GGT); - oznaczenie stężenia bilirubiny całkowitej i bezpośredniej; - ocena stężenia międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR); - oznaczenie stężenia kreatyniny i mocznika; - oznaczenie poziomu witamin rozpuszczalnych w tłuszczach: A, D, E; - oznaczenie stężenia cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL, cholesterolu LDL i triglicerydów (lipidogram); - badanie przedmiotowe wraz z oceną nasilenia świądu z użyciem 5-punktowej skali ItchRO(Obs); - badania ultrasonograficzne jamy brzusznej (ocena wątroby, dróg żółciowych, śledziony oraz układu

7) adekwatna wydolność narządowa określona na podstawie wyników badań laboratoryjnych umożliwiające w opinii lekarza prowadzącego bezpieczne rozpoczęcie terapii; 8) wykluczenie ciąży i okresu karmienia piersią. Powyższe kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie. Ponadto do programu lekowego kwalifikowani są również pacjenci, którzy byli leczeni w ramach innego sposobu finansowania terapii, pod warunkiem, że w chwili rozpoczęcia leczenia spełniali kryteria kwalifikacji do programu lekowego. Do programu włączane są, po zweryfikowaniu ogólnego stanu zdrowia pacjenta umożliwiającego leczenie w programie, bez konieczności ponownej kwalifikacji, pacjentki wyłączone z programu w związku z ciążą lub karmieniem piersią, które w momencie wyłączenia spełniały pozostałe kryteria przedłużenia leczenia. Do programu włączani są ponownie pacjenci, którzy zakwalifikowali się do leczenia w ramach programu i po 24 miesiącach leczenie zostało zawieszone w celu sprawdzenia czy jest ono nadal wymagane, i u których po 4 tygodniach obserwacji stwierdzono wzrost nasilenia świądu w oparciu o wynik w skali ItchRO(Obs) o co najmniej 1 punkt. 2. Kryteria uniemożliwiające włączenie do programu 1) nadwrażliwość na maraliksiyat lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; 2) chirurgiczne przerwanie krążenia jelitowo-wątrobowego; 3) historia przeszczepienia wątroby;		moczowego); 13) pomiary antropometryczne - wzrost, masa ciała, BMI (u dzieci); 14) test ciążowy (u kobiet w wieku rozrodczym). 2. Monitorowanie bezpieczeństwa leczenia Pierwsze badanie monitorujące należy wykonać po 4 tygodniach, od rozpoczęcia leczenia maraliksiybatem. Badania kontrolne wykonywane nie rzadziej niż raz na miesiąc, a po stabilizacji stanu klinicznego, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące: 1) morfologia krwi z rozmazem; 2) oznaczenie stężenia kwasów żółciowych; 3) oznaczenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej (AST); 4) oznaczenie aktywności aminotransferazy alaninowej (ALT); 5) oznaczenie aktywności gamma glutamylotransferazy (GGT); 6) oznaczenie stężenia bilirubiny całkowitej i bezpośredniej; 7) oznaczenie stężenia kreatyniny i mocznika; 8) badanie przedmiotowe wraz z oceną nasilenia świądu z użyciem 5-punktowej skali ItchRO(Obs); 9) oznaczenie stężenia cholesterolu całkowitego, cholesterolu HDL, cholesterolu LDL i triglicerydów (lipidogram); 10) test ciążowy (u kobiet w wieku rozrodczym). Badania kontrolne wykonywane nie rzadziej niż raz na 3 miesiące: 1) oznaczenie poziomu witamin rozpuszczalnych w
---	--	--

4) zdekompensowana marskość wątroby; 5) wcześniejsza lub obecna inna współistniejąca choroba wątroby; 6) przewlekła biegunka wymagająca stałego podawania płynów dożylnie lub interwencji żywieniowej; 7) występowanie lub obecność w przeszłości jakiegokolwiek innej choroby lub stanów, o których wiadomo, że zaburzą wchłanianie, dystrybucję, metabolizm lub wydalanie leków, w tym metabolizm soli żółciowych w jelicie. 3. Określenie czasu leczenia w programie Czas leczenia maraliksibatem w programie określa lekarz na podstawie kryteriów włączenia i kryteriów wyłączenia z programu. Po 24 miesiącach leczenia podawanie leku zostaje zawieszone w celu oceny po 4 tygodniach obserwacji czy objawy świądu powrócą. Jeżeli po 4 tygodniach obserwacji stwierdzi się wzrost nasilenia świądu w oparciu o wynik w skali ItchRO(Obs) o co najmniej 1 punkt pacjent automatycznie zostaje zakwalifikowany ponownie do leczenia w ramach programu. W przypadku zajścia w ciążę leczenie maraliksibatem zostaje zawieszone. W trakcie zawieszenia terapii pacjentka pozostaje w programie lekowym i jest obserwowana w zakresie kontroli objawów choroby. Po porodzie i okresie karmienia piersią lekarz może zdecydować o ponownym rozpoczęciu podawania leku w przypadku istotnego pogorszenia kontroli choroby.		tłuszczach: A, D, E; 2) ocena stężenia międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR); 3) badania ultrasonograficzne jamy brzusznej (ocena wątroby, dróg żółciowych, śledziony oraz układu moczowego); 4) pomiary antropometryczne - wzrost, masa ciała, BMI (u dzieci); 5) konsultacje w razie wskazań klinicznych: okulistyczna, neurologiczna, kardiologiczna, nefrologiczna, gastrologiczna. Regularne monitorowanie w celu odpowiedniego nawodnienia u świadczeniobiorców, u których występuje biegunka. 3. Ocena skuteczności leczenia Skuteczność leczenia maraliksibatem oceniana jest na podstawie: 1) stężenia kwasów żółciowych w surowicy krwi – leczenie uznaje się za skuteczne jeśli nastąpi zmniejszenie stężenia kwasów żółciowych w surowicy o co najmniej 50% względem wartości początkowych lub zostanie osiągnięte stężenie $\leq 70 \mu\text{mol/l}$; 2) oceny świądu wg skali specyficznej dla schorzenia wg obserwatora ItchRO(Obs) – opiekunowie pacjenta wypełniają codziennie rano i wieczorem kwestionariusz ItchRO(Obs). Ocenie poddawane są wyniki średnie z każdego tygodnia obserwacji. Leczenie uznaje się za skuteczne jeśli zostanie osiągnięta pozytywna ocena świądu rozumiana jako zmniejszenie nasilenia świądu o co najmniej jeden punkt w porównaniu do wartości wyjściowej (w momencie kwalifikacji do programu) w
--	--	---

4. Kryteria wyłączenia z programu 1) brak skuteczności leczenia stwierdzony na podstawie oceny głównych wskaźników efektywności terapii i oczekiwanych korzyści zgodnie z treścią pkt. 3. <i>Ocena skuteczności leczenia</i>; 2) wystąpienie objawów nadwrażliwości na którąkolwiek substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą; 3) stwierdzenie nieakceptowalnej lub zagrażającej życiu toksyczności pomimo zastosowania adekwatnego postępowania; 4) wystąpienie chorób lub stanów, które w opinii lekarza prowadzącego uniemożliwiają dalsze prowadzenie leczenia; 5) pogorszenie jakości życia o istotnym znaczeniu według oceny lekarza prowadzącego; 6) okres ciąży lub karmienia piersią – gdy leczenie nie zostaje zawieszono zgodnie z opisem w <i>Określenie czasu leczenia w programie</i>; 7) brak współpracy lub nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich, w tym zwłaszcza dotyczących okresowych badań kontrolnych oceniających skuteczność i bezpieczeństwo leczenia ze strony świadczeniobiorcy lub jego prawnych opiekunów; 8) pacjent, u którego zaprzestano podawania substancji czynnej wymienionej w programie i zastosowanej zgodnie z jego treścią z powodu nieskuteczności lub braku odpowiedzi na leczenie nie powinien być ponownie włączany do terapii tą samą substancją czynną.		ostatnich 6 tygodniach 3 miesięcznego okresu obserwacji. Ocenę skuteczności leczenia <i>maraliksiybatem</i> na podstawie powyższych badań laboratoryjnych i obrazowych wykonuje się w 3 miesiącu od rozpoczęcia terapii, następnie co 3 miesiące. Odpowiedź kliniczna na leczenie <i>maraliksiybatem</i>, definiowana jest jako spełnienie jednego z warunków określonych w punktach 1 i 2. 4. Monitorowanie programu 1) gromadzenie w dokumentacji medycznej pacjenta danych dotyczących monitorowania leczenia i każdorazowe ich przedstawianie na żądanie kontrolerów Narodowego Funduszu Zdrowia; 2) uzupełnianie danych zawartych w elektronicznym systemie monitorowania programów lekowych dostępnym za pomocą aplikacji internetowej udostępnionej przez OW NFZ, z częstotliwością zgodną z opisem programu oraz na zakończenie leczenia, w tym przekazywanie danych dotyczących wskaźników efektywności: a) stężenia kwasów żółciowych, b) oceny świądu oraz jakości snu wg skali ItchRO(Obs), c) zmiany stężenia parametrów laboratoryjnych wyszczególnionych w pkt 2 <i>Monitorowanie bezpieczeństwa leczenia</i>. 3) przekazywanie informacji sprawozdawczo rozliczeniowych do NFZ (informacje przekazuje się do NFZ w formie papierowej lub w formie elektronicznej) zgodnie z wymaganiami opublikowanymi przez NFZ.
--	--	---

5. Kryteria ponownego włączenia do programu

- 1) do programu może być ponownie włączony pacjent, u którego zaprzestano podawania substancji czynnej wymienionej w programie i zastosowanej zgodnie z jego treścią z powodu wystąpienia działań niepożądanych, które ustąpiły po odstawieniu leku bądź zastosowanym leczeniu i w opinii lekarza prowadzącego powrót do terapii tą samą substancją czynną nie stanowi ryzyka dla pacjenta, przy spełnieniu przez niego kryteriów kwalifikacji oraz braku spełnienia kryteriów wykluczenia, w sytuacji gdy wstrzymanie leczenia trwało nie dłużej niż 3 miesiące;
- 2) do programu może być ponownie włączony pacjent, u którego zaprzestano podawania substancji czynnej wymienionej w programie z powodu wystąpienia chorób współistniejących i sytuacji niezależnych od pacjenta, po ustąpieniu wyżej wymienionych okoliczności, jeżeli w opinii lekarza prowadzącego powrót do terapii tą samą substancją czynną nie stanowi ryzyka dla pacjenta, przy spełnieniu przez niego kryteriów kwalifikacji oraz braku spełnienia kryteriów wykluczenia, w sytuacji gdy wstrzymanie leczenia trwało nie dłużej niż 3 miesiące.